中性粒细胞产生酶最活跃

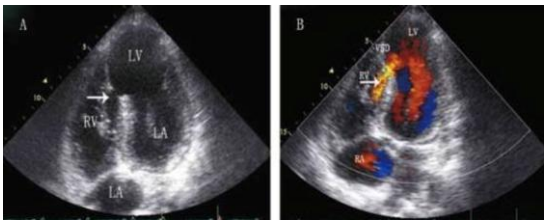
7.心脏破裂（起病 1 周内多见）　Beck三联征:动脉压低、静脉压高,心音低弱遥远

两边没有支撑

①心室游离壁破裂多见：心包积血→急性心脏压塞→心包穿刺；无脉性电活动　电信号还在,但机械活动消失

②**室间隔破裂：胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音**

VS十二指肠溃疡前壁(游离壁)容易发生急性穿孔



胸骨左缘3-4肋间听到舒张期杂音:主闭
胸骨左缘3-4肋间听到收缩期杂音:肥厚型心肌病、室间隔穿孔破裂(有心梗病史)、先天性室缺(亚急性心内膜炎)
胸骨左缘3-4肋间听到搔刮音:急非特、Dressler综合征
胸骨左缘3-4肋间听到心包叩击音:缩窄性心包炎、心包积液

8.栓塞

一开始在左心,可发展到右心

注意：主要致体循环栓塞、也可致肺栓塞的疾病：急性冠脉综合征、扩心病（右心附壁血栓脱落）、伴室缺的亚心炎（赘生物脱落）

在慢性期,瘢痕已经长好

9.室壁瘤　VS STEMI的ST段不会一直抬高

①左侧心界扩大、心脏搏动范围广、心电图 **ST 段持续抬高**

②**首选超声心动图**：局部心缘突出、**反常搏动/矛盾运动**



10.急性左心衰

①突发喘憋、**端坐呼吸**、**咳粉红色泡沫样痰**、双肺湿啰音

利尿　扩V　扩A

②用呋塞米、硝酸酯类、硝普钠、吗啡；**禁用 β-R 拮抗剂、强心苷（急性心梗 24 小时内禁用）**

强心利尿扩管打吗啡　慢性左心衰可以用,因为可以抗重构

③评估急性心梗所致心衰（泵衰竭）

Killip 分级（1 无 23 啰 4 休克、倒着看）：kill:心肌被杀死了		
I：无明显心衰	II：有左心衰、肺部啰音**＜50%**（1个肺叶或双肺底少量啰音） III：肺部啰音**＞50%**（急性肺水肿）	**IV：心源性休克**（**收缩压＜90**、PAWP/PCWP≥18、CI≤2.2）　肺小A楔压/肺CAP楔压
Forrester 分类		ARDS:非心源性肺水肿(PAWP/PCWP<18)
I：无肺淤血和周围灌注不足	II：单有肺淤血（PAWP≥18、CI＞2.2）　肺有左右 III：单有周围灌注不足（PAWP＜18、CI≤2.2）	IV：有肺淤血和周围灌注不足

坏死物吸收

咏心梗：胸痛发热血压低、心律乱头心脏破、栓塞壁瘤急性左、Killip Forrester 心包摩

数小时　心源性休克

（三）急性 ST 段抬高型心梗的治疗　冠脉已经完全闭掉

1.再灌注治疗（解除疼痛最有效）

（1）在起病 3-6 小时、最多 12 小时内进行（对比：急性肺血栓栓塞溶栓时间窗≤14 天）肺双重血供,三重氧供

恶性心律失常,容易导致猝死

（2）再灌注治疗前尽早用 **β-R 拮抗剂**（缓解疼痛、明显降低死亡率、预防室速室颤），吗啡或哌替啶，硝酸酯类

循证医学证明能减少心律失常猝死　β-R拮抗剂:抗快速心律失常的药物　胺碘酮:抗快速心律失常的药物